THAMYRES TOSARELLI

FACETA DIRETA EM RESINA COMPOSTA

Revisão de literatura

1 INTRODUÇÃO

A aparência do sorriso tem um peso cada vez maior na forma como as pessoas se veem e são vistas. Soares e Borges (2023) observaram que a estética dental passou a ser procurada não só por saúde, mas também por autoestima, aceitação social e bem-estar, e que essa procura cresceu bastante com a influência das redes sociais. Rocha et al. (2021) explicaram que dentes com alteração de cor, forma ou posição costumam ser percebidos como fora do padrão divulgado pela mídia, o que pode gerar insegurança, timidez e até isolamento, levando o paciente ao consultório em busca de uma solução. Bento et al. (2021) mostraram que esse impacto não é apenas subjetivo: no caso relatado pelos autores, a qualidade de vida do paciente, medida pelo questionário OHIP-14, melhorou de forma clara após o tratamento estético.

Silva, I. et al. (2021) apontaram que as queixas mais frequentes dos pacientes envolvem a cor dos dentes, o contorno inadequado e a presença de diastemas, e que, para resolvê-las, o cirurgião-dentista pode indicar clareamento dental, tratamento ortodôntico, laminados cerâmicos ou facetas diretas em resina composta, muitas vezes combinando essas opções. Lima et al. (2020) destacaram que, no caso dos diastemas, as restaurações diretas oferecem tempo reduzido de trabalho, baixo custo e resultado imediato.

Alves, Peres e Lima (2022) e Brito, Ferreira e Yamashita (2022) descreveram as facetas como procedimentos que recobrem a face vestibular dos dentes para melhorar sua estética e função, podendo ser confeccionadas de forma direta, com resina composta aplicada no próprio consultório, ou de forma indireta, com peças de cerâmica ou de resina produzidas em laboratório. Korkut, Yanıkoğlu e Günday (2013) e Soares e Borges (2023) destacaram as vantagens da técnica direta: exige pouco ou nenhum desgaste do dente, pode ser concluída em uma única sessão, dispensa etapas laboratoriais, tem custo menor e permite reparos dentro da boca.

Boa parte dessa popularidade se deve à evolução das próprias resinas compostas. Lanzaretti et al. (2025) e Dominguez et al. (2024) relataram que os materiais nano-híbridos e nanoparticulados melhoraram o polimento, a resistência e a estabilidade de cor, permitindo restaurações cada vez mais próximas do dente natural. Nalbandian e Millar (2009), em um estudo com pacientes tratados com facetas de resina ou de porcelana, não encontraram diferença na melhora estética percebida pelos próprios pacientes entre os dois materiais, o que reforça a resina como uma alternativa válida e mais conservadora.

Por outro lado, a técnica não está livre de problemas. Korkut, Yanıkoğlu e Günday (2013) lembraram que as facetas diretas são mais suscetíveis ao desgaste, ao manchamento e à fratura, e Cruz et al. (2023) apontaram que grande parte das falhas está ligada à execução do profissional e a fatores do próprio paciente, como hábitos parafuncionais e higiene deficiente. Reis et al. (2018) mostraram que o sucesso também depende de um bom planejamento, com recursos como o enceramento diagnóstico e o mock-up, e Santos et al. (2022) alertaram para o respeito aos tecidos periodontais, já que facetas mal adaptadas podem causar inflamação gengival.

Mesmo sendo um tratamento muito difundido, a literatura ainda não chegou a um consenso sobre a durabilidade das facetas diretas quando comparadas às indiretas. Galvão et al. (2025), em uma revisão sistemática recente, apontaram maior sobrevida para as facetas diretas, enquanto Teixeira et al. (2022) observaram vantagem das facetas indiretas de porcelana. Diante disso, torna-se importante reunir o que os estudos mostram sobre as indicações, a técnica, o planejamento e a longevidade das facetas diretas em resina composta, para que o cirurgião-dentista possa indicá-las com segurança e executá-las com previsibilidade.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Realizar uma revisão de literatura sobre as facetas diretas em resina composta em dentes anteriores, abordando suas indicações, a técnica de confecção, o planejamento e a longevidade clínica.

2.2 Objetivos específicos

a) contextualizar a busca pela estética do sorriso e a evolução dos materiais restauradores estéticos;
b) descrever a composição, a classificação e o desempenho das resinas compostas e dos sistemas adesivos;
c) apresentar o conceito, as indicações, as contraindicações, as vantagens e as desvantagens das facetas diretas em resina composta;
d) descrever as etapas de planejamento e a técnica de confecção das facetas diretas, incluindo o acabamento e o polimento;
e) discutir a relação entre as facetas diretas e os tecidos periodontais;
f) analisar a longevidade, as principais falhas e a manutenção das facetas diretas, comparando-as com as facetas indiretas.

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 A estética do sorriso

O sorriso é considerado um dos recursos mais importantes da expressão facial. Segundo Silva, I. et al. (2021), a partir da década de 1990 houve um aumento claro na valorização da estética dental, associada a dentes brancos, alinhados e bem contornados. Para esses autores, a harmonia do sorriso depende da simetria dos dentes entre si e com a linha média da face, em equilíbrio com a gengiva, os lábios e o rosto, de modo que assimetrias de tamanho, espaçamento ou cor acabam prejudicando a forma como o paciente percebe a própria aparência.

Essa valorização ganhou ainda mais força nos últimos anos. Soares e Borges (2023) observaram que a odontologia estética cresceu muito com a influência das redes sociais e que a aparência passou a ser um determinante da autoestima, fazendo com que a estética dental seja procurada por saúde, aceitação social e bem-estar. Rocha et al. (2021) acrescentaram que a falta de harmonia no sorriso pode gerar ansiedade, insegurança, timidez e até isolamento social, e que muitos pacientes buscam tratamentos que influenciem a sua autoimagem, e não apenas a função.

Algumas alterações de forma, mesmo sem comprometer a saúde bucal, têm grande impacto na estética. Lanzaretti et al. (2025) citaram como exemplo os incisivos laterais conoides, que podem atingir até 2,5% da população e costumam vir acompanhados de diastemas e assimetrias que levam o paciente a procurar tratamento. Bento et al. (2021) mediram o impacto dessas correções na vida do paciente aplicando o questionário de qualidade de vida OHIP-14 antes e depois de uma reabilitação com facetas diretas, e a pontuação caiu de 24 para 5 pontos, o que indica uma melhora importante na qualidade de vida relacionada à saúde bucal.

Por isso, o planejamento estético não pode olhar apenas para os dentes. Dominguez et al. (2024) destacaram que a simetria facial, as proporções dentárias, a linha do sorriso e a exposição gengival devem ser consideradas para definir o tratamento mais adequado, e Cruz et al. (2023) reforçaram que a análise deve incluir a face, os lábios, os materiais e as técnicas que serão empregados para que o resultado seja harmonioso e natural.

3.2 Evolução dos materiais restauradores estéticos

A preocupação em melhorar a aparência dos dentes não é recente. Alves, Peres e Lima (2022) relataram que as facetas surgiram na década de 1930, quando Charles Pincus as desenvolveu para realçar o sorriso de atores americanos. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) lembraram que, durante muito tempo, as opções foram limitadas e que, no começo do século XX, a maior parte dos procedimentos odontológicos se resumia a extrações, e só aos poucos foram surgindo materiais capazes de devolver estética e função.

Lanzaretti et al. (2025) relataram que as primeiras restaurações estéticas eram feitas com cimentos de silicato e, no início da década de 1950, passaram a ser feitas com resinas acrílicas de polimetilmetacrilato. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) e Lanzaretti et al. (2025) destacaram que, no mesmo período, Buonocore desenvolveu a técnica do condicionamento ácido do esmalte com ácido fosfórico, que permitiu unir a restauração ao dente e selar suas margens, sendo considerada um marco para a odontologia adesiva.

Alves, Peres e Lima (2022) relataram que as resinas compostas foram introduzidas há cerca de 50 anos e que, desde então, sua composição evoluiu muito. Nalbandian e Millar (2009) lembraram que as primeiras facetas diretas em resina, usadas no fim da década de 1970 e início da de 1980, decepcionaram por apresentarem pouca estabilidade de cor, perda do polimento e desgaste, mas que as resinas atuais têm propriedades físicas e estéticas muito superiores, o que permite tratamentos minimamente invasivos com resultado imediato. Para Silva, I. et al. (2021), essa evolução foi especialmente marcante nos últimos 20 anos, com resinas de melhores propriedades mecânicas, físicas e ópticas e sistemas adesivos com maior capacidade de união ao dente.

Cruz et al. (2023) apontaram como um passo importante dessa evolução as resinas nano-híbridas e nanoparticuladas, que surgiram em meados dos anos 2000 com resistência semelhante à das micro-híbridas e polimento semelhante ao das microparticuladas. Mesmo com esses avanços, Alves, Peres e Lima (2022) ressaltaram que as resinas ainda apresentam limitações, como a contração de volume durante a polimerização e o estresse gerado por ela.

3.3 Resinas compostas

3.3.1 Composição e classificação

Soares e Borges (2023) explicaram que as resinas compostas são formadas por uma matriz orgânica, uma parte inorgânica, um sistema iniciador e um agente de união, sendo a matriz orgânica composta por monômeros que se transformam em polímeros durante a polimerização. Segundo esses autores, as resinas podem ser diferenciadas pelo tamanho e pelo tipo das partículas de carga e da matriz.

Cruz et al. (2023) explicaram que a classificação das resinas se baseia no tamanho médio das partículas de carga, na viscosidade e na forma de ativação. Quanto ao tamanho das partículas, elas podem ser macroparticuladas, microparticuladas, micro-híbridas (ou híbridas) e nanoparticuladas, e há ainda as resinas supra-nano, com partículas próximas de 200 nanômetros e comportamento parecido com o das nanoparticuladas. Quanto à viscosidade, podem ser de baixa, média ou alta, sendo a maioria das resinas atuais de viscosidade média, e quanto à ativação, podem ser fotoativadas ou ativadas quimicamente.

Cada tipo tem um comportamento diferente. Dominguez et al. (2024) relataram que as resinas microparticuladas oferecem acabamento superior e são fáceis de manipular, mas têm menor resistência mecânica, o que limita seu uso em áreas de grande esforço mastigatório, enquanto as nano-híbridas, por combinarem nanopartículas com partículas maiores, mantêm um polimento duradouro e resistem melhor ao desgaste e à fratura. Soares e Borges (2023) explicaram que, nas nanoparticuladas, as partículas chegam a 0,02 µm, o que proporciona superfície ainda mais lisa, ótimo brilho e boas propriedades mecânicas. Silva, I. et al. (2021) acrescentaram que essas resinas reproduzem bem a fluorescência e a opacidade do dente, têm menor contração de polimerização e boa estabilidade de cor.

Na prática, a escolha depende da situação clínica. Lima et al. (2020) indicaram a resina microparticulada como material de eleição para fechar diastemas de até 2 mm, pelo polimento semelhante ao do esmalte e pela translucidez, e justificaram o uso das nano-híbridas por unirem bom polimento à resistência das resinas híbridas. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) também observaram que as resinas microparticuladas e nanoparticuladas ficam com superfície mais lisa após o polimento do que as micro-híbridas, o que favorece a estética e a longevidade em

dentes anteriores. Já Cruz et al. (2023) lembraram que, apesar do alto polimento, as microparticuladas têm resistência limitada quando é preciso reconstruir grandes volumes.

3.3.2 Desempenho clínico e laboratorial

As diferenças entre os tipos de resina aparecem também na boca. Irgang et al. (2020) avaliaram retrospectivamente 74 facetas diretas em 28 pacientes, com média de três anos de uso, comparando resinas microparticuladas e universais por meio dos critérios FDI e USPHS. A taxa de sobrevivência foi de 77%, e as três perdas totais ocorreram no grupo das universais. As microparticuladas tiveram melhor desempenho em brilho, manchamento, correspondência de cor e adaptação marginal, o que confirma, na clínica, a vantagem estética descrita pelos autores citados anteriormente.

Resinas mais recentes também vêm mostrando bons resultados. Bastos et al. (2018) acompanharam por seis meses facetas diretas feitas com uma resina de carga supra-nano esférica em uma paciente com dentes escurecidos e bruxismo, e observaram bom aspecto clínico, sem acúmulo de biofilme nem desgaste abrasivo, sugerindo desempenho promissor desse tipo de material.

Além do tipo de resina, a forma de polimerizar influencia as propriedades finais. Fernandes et al. (2022) compararam em laboratório a microdureza das resinas Filtek Z350 XT e Filtek One Bulk Fill polimerizadas pela técnica imediata ou pela técnica de pulso tardio, em 40 corpos de prova. A técnica imediata produziu dureza significativamente maior, e a Z350 XT foi mais dura que a bulk fill nas duas técnicas.

Os hábitos do paciente também pesam. Tozo-Burgos, Escalante-Otárola e Sánchez-Tito (2025) imergiram cinco resinas de alta translucidez em uma bebida energética por dez minutos ao dia, durante 30 dias, e verificaram que todas perderam dureza e ficaram mais rugosas. A Filtek Z350 XT manteve a maior dureza, enquanto a Beautifil II foi a mais afetada, levando os autores a concluir que materiais com nanoaglomerados e zircônia resistem melhor à degradação ácida. Esse resultado mostra que, além de escolher bem o material, o profissional precisa orientar o paciente sobre a dieta para preservar a faceta.

3.4 Sistemas adesivos

Toda faceta direta depende da adesão, já que a resina precisa ficar firmemente unida ao dente. Dominguez et al. (2024) descreveram o condicionamento com ácido fosfórico como uma etapa fundamental, pois remove a camada superficial de hidroxiapatita e cria uma superfície microrretentiva para a resina. Segundo os mesmos autores, o sistema adesivo funciona como uma ponte entre a resina e a estrutura dental, melhorando a união e selando as margens da restauração.

Os protocolos descritos nos artigos são bastante parecidos. Alves, Peres e Lima (2022) relataram a aplicação de ácido fosfórico a 37% por 30 segundos no esmalte e 15 segundos na dentina, lavagem por 20 segundos, secagem, duas aplicações do sistema adesivo e fotoativação por 40 segundos. Soares e Borges (2023) citaram um protocolo com condicionamento por 30 segundos no esmalte, lavagem por 60 segundos e adesivo universal fotoativado por 20 segundos. Galvão et al. (2025) observaram, em sua revisão sistemática, que a maioria dos estudos clínicos incluídos utilizou o sistema Clearfil SE Bond, considerado padrão-ouro na adesão ao esmalte e à dentina.

Para Brito, Ferreira e Yamashita (2022), a adesão precisa respeitar as propriedades químicas e físicas de cada produto, porque qualquer etapa mal executada pode comprometer a interface adesiva. Nessa mesma linha, Lima et al. (2020) afirmaram que o sucesso das facetas depende de o cirurgião-dentista compreender os princípios básicos dos sistemas adesivos e das resinas atuais, e Cruz et al. (2023) destacaram que a escolha correta da resina, do adesivo e do aparelho fotopolimerizador é essencial para a qualidade da técnica. Silva, I. et al. (2021) ressaltaram que foi justamente a evolução dos sistemas adesivos que tornou possível, em muitos casos, reabilitar os dentes com preparos mínimos ou sem desgaste algum.

3.5 Facetas diretas em resina composta

3.5.1 Conceito

Silva, I. et al. (2021), Brito, Ferreira e Yamashita (2022) e Cruz et al. (2023) definiram as facetas como restaurações que recobrem a face vestibular do dente

com um material restaurador fixado por meio de sistemas adesivos, podendo ser confeccionadas de forma direta, com resina composta, ou indireta, com cerâmica ou resina processada fora da boca. Korkut, Yanıkoğlu e Günday (2013) explicaram que as facetas diretas são aplicadas sobre o dente diretamente no consultório, enquanto as indiretas são produzidas em laboratório e depois cimentadas.

Soares e Borges (2023) consideraram a faceta direta um procedimento menos invasivo, já que, na maioria dos casos, não exige preparo prévio, a não ser quando o dente precisa de ajustes de anatomia. Santos et al. (2022), porém, fizeram uma ressalva importante: embora as facetas diretas sejam mais conservadoras que as indiretas, elas não são a mais conservadora das restaurações diretas, devendo ser indicadas com critério.

3.5.2 Indicações

As facetas diretas podem resolver um grande número de problemas estéticos. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) listaram como indicações as alterações de cor e de forma, os dentes escurecidos ou manchados, a amelogênese imperfeita, as microdontias, as alterações de posição e as perdas de estrutura por desgaste. Lima et al. (2020) consideraram as restaurações diretas uma opção de destaque para o fechamento de diastemas, e Silva, I. et al. (2021) acrescentaram que, quando existe apenas uma pequena desproporção entre os dentes, as facetas podem substituir o tratamento ortodôntico com resultado mais rápido.

Os relatos de caso mostram essa variedade na prática. Korkut, Yanıkoğlu e Günday (2013) utilizaram facetas diretas em três pacientes com fraturas incisais, escurecimento e uma restauração antiga deficiente. Dias et al. (2020) trataram manchas brancas de lesões de cárie inativa em uma paciente de 21 anos, e Vookanti et al. (2026) usaram a técnica para mascarar manchas de fluorose moderada. Joshi (2025), em um dente desvitalizado e escurecido, realizou clareamento interno antes das facetas, enquanto Falcão et al. (2023), diante de um dente em que um novo clareamento interno estava contraindicado, recorreram a pigmentos opacificadores para bloquear o escurecimento.

Quando o desalinhamento é maior, a escolha do material pode mudar. Vaz, Lopes e Toledo Neta (2022) relataram o caso de uma paciente de 21 anos em que a reabilitação estética foi usada como alternativa à ortodontia, com cerâmica de

dissilicato de lítio nos seis dentes anteriores e resina composta Z350 XT nos pré-molares, o que mostra que os dois materiais podem ser combinados em um mesmo planejamento.

3.5.3 Contraindicações

Nem todo paciente é um bom candidato às facetas. Cruz et al. (2023) contraindicaram o tratamento em pacientes com doença periodontal grave, sobremordida acentuada, bruxismo e má higiene bucal. Santos et al. (2022) ampliaram essa lista, incluindo dentes sem suporte saudável, com menos de 50% de esmalte, muito vestibularizados, com múltiplas restaurações ou com grande giroversão, além de bruxismo não tratado, periodontite grave, oclusão topo a topo, mordida cruzada e apinhamento.

O bruxismo aparece em quase todos os trabalhos como um fator de risco. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) observaram que, em pacientes com bruxismo severo, as facetas de resina têm limitações funcionais e exigem manutenção para repolimento. Teixeira et al. (2022) relataram que o bruxismo também aumenta a taxa de insucesso das facetas indiretas e que os descolamentos são mais frequentes quando o paciente não usa a placa miorrelaxante recomendada.

3.5.4 Vantagens e desvantagens

As vantagens das facetas diretas são citadas de forma muito parecida pelos autores. Korkut, Yanıkoğlu e Günday (2013) destacaram a ausência de preparo ou o preparo mínimo, o menor custo, a reversibilidade, a dispensa de cimentação, o polimento fácil, a possibilidade de reparar trincas e fraturas na boca e a boa adaptação marginal. Silva, I. et al. (2021) acrescentaram a possibilidade de concluir o tratamento em uma única sessão, e Cruz et al. (2023) consideraram a técnica mais conservadora, mais barata e mais rápida que as facetas cerâmicas, por não depender de etapa laboratorial. Alves, Peres e Lima (2022) ressaltaram ainda a capacidade da resina de reproduzir morfologia, cor, translucidez e opacidade.

As desvantagens, por outro lado, estão ligadas principalmente ao material. Segundo Korkut, Yanıkoğlu e Günday (2013), as facetas diretas têm menor resistência ao desgaste e estão mais sujeitas a manchamento e fraturas. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) citaram a perda de brilho e o amarelamento mais

rápido, e Lanzaretti et al. (2025) apontaram a necessidade de manutenção periódica. Alves, Peres e Lima (2022) observaram que a resistência mecânica pode ser inferior à das restaurações indiretas, e Silva, I. et al. (2021) lembraram que a técnica exige habilidade manual e atenção na seleção de cor e no acabamento.

Mesmo com essas limitações, a percepção do paciente costuma ser favorável. Nalbandian e Millar (2009) compararam a opinião de 96 pacientes tratados com dez facetas de resina ou dez de porcelana e não encontraram diferença na melhora estética percebida entre os dois materiais. A conservação do dente, o tempo de tratamento e os custos de reparo e substituição favoreceram a resina, e os autores concluíram que, quando bem informados, os pacientes podem preferir a opção mais conservadora.

3.6 Planejamento

Os autores concordam que o resultado de uma faceta direta é definido, em grande parte, antes de se aplicar a resina. Cruz et al. (2023) explicaram que o planejamento começa pela anamnese e pelo exame clínico, incluindo teste de vitalidade e radiografias para verificar lesões de cárie, alterações periapicais e restaurações existentes. Lanzaretti et al. (2025) recomendaram, em seguida, fotografias intra e extraorais e modelos de estudo para a confecção do enceramento diagnóstico. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) acrescentaram que o enceramento deve reproduzir proporção dentária, pontos de contato, arquitetura gengival, bordas incisais, inclinação axial e zênites gengivais.

A partir do enceramento, é possível fazer o mock-up, um ensaio restaurador na boca do paciente. Reis et al. (2018) relataram um caso em que o mock-up com resina bisacrílica foi ajustado de acordo com as observações da própria paciente antes das facetas definitivas, e concluíram que essa etapa motivou a paciente e trouxe previsibilidade e segurança tanto para ela quanto para o profissional. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) reforçaram que, sem o mock-up, o profissional tem dificuldade para visualizar a forma, a posição e a proporção das futuras restaurações. Bento et al. (2021) também utilizaram fotografias, enceramento e mock-up antes de confeccionar as facetas de um paciente com diastema.

O planejamento digital tem ganhado espaço. Silva, B. et al. (2021) utilizaram o planejamento digital para definir as medidas ideais dos dentes antes de uma cirurgia

periodontal e das facetas, e Soares e Borges (2023) citaram seu uso para orientar o enceramento diagnóstico. Joshi (2025) mostrou que, em casos mais complexos, o planejamento precisa ser feito em etapas: no caso relatado, a paciente passou por tratamento das cáries, endodontia com clareamento interno e aumento de coroa antes das facetas.

O clareamento dental antes das facetas aparece em boa parte dos casos. Pereira et al. (2020) realizaram três sessões de clareamento com peróxido de hidrogênio a 35% e aguardaram 21 dias para a estabilização da cor antes de escolher a cor da resina. Rocha et al. (2021) observaram que o clareamento prévio reduziu a necessidade de desgaste e permitiu uma camada mais fina de resina, com aspecto mais natural. Reis et al. (2018), Bastos et al. (2018), Dias et al. (2020) e Bento et al. (2021) também realizaram o clareamento antes das facetas.

3.7 Técnica de confecção

Embora cada caso tenha suas particularidades, os artigos descrevem uma sequência de passos bastante semelhante. Lanzaretti et al. (2025) recomendaram uma profilaxia profissional dois dias antes do procedimento e, no dia do atendimento, a seleção de cor pela técnica do botão, em que pequenas porções de resina são polimerizadas sobre o dente para testar a cor. Oliveira et al. (2021) usaram a mesma lógica, aplicando incrementos de resina nos terços cervical, médio e incisal sem condicionamento ácido, e Vookanti et al. (2026) também empregaram a técnica do botão. Pereira et al. (2020), por sua vez, associaram a escala de cores à prova de incrementos de resina, sob luz natural.

O isolamento do campo operatório é outro ponto em comum. Alves, Peres e Lima (2022) e Lanzaretti et al. (2025) indicaram o isolamento absoluto com dique de borracha, e Oliveira et al. (2021) optaram por um isolamento absoluto modificado para permitir o uso da guia palatina. Alves, Peres e Lima (2022) descreveram, quando há necessidade de preparo, a redução vestibular e incisal com remoção das restaurações insatisfatórias. Vookanti et al. (2026) mantiveram o preparo mínimo, limitando o desgaste às áreas manchadas, com cerca de 0,5 a 0,75 mm no terço médio.

Oliveira et al. (2021), Pereira et al. (2020) e Lanzaretti et al. (2025) descreveram que, depois do condicionamento ácido e da aplicação do adesivo, a

guia de silicone obtida do enceramento é posicionada para construir a parede palatina, que serve de base para o restante da faceta. Lanzaretti et al. (2025) detalharam que, em seguida, são construídas as paredes proximais e a resina é aplicada em camadas. Pereira et al. (2020) utilizaram incrementos de resina para dentina e para esmalte, e Reis et al. (2018) combinaram a IPS Empress Direct, por sua menor opacidade, na dentina, com a Filtek Z350, pela facilidade de manipulação, no esmalte. Rocha et al. (2021) empregaram ainda resinas de efeito para reproduzir a opalescência e os detalhes típicos dos dentes jovens.

Em dentes muito escurecidos, a estratificação precisa de recursos extras. Falcão et al. (2023) aplicaram uma mistura fluida de três pigmentos opacificadores sobre o dente 21, conferiram o valor da camada por fotografias em preto e branco e só então fizeram a estratificação com resina translúcida na palatina, resina de dentina opaca e resina acromática translúcida no esmalte, obtendo cor estável após sete meses. Vookanti et al. (2026), nos casos de fluorose, observaram que o próprio preparo removeu boa parte das manchas, dispensando o uso de opacificadores, e a faceta foi feita com resina nano-híbrida em camadas policromáticas.

3.8 Acabamento e polimento

O acabamento e o polimento são etapas que muitos autores colocam no mesmo nível de importância que a própria estratificação. Dominguez et al. (2024) afirmaram que essas etapas influenciam diretamente a estética, a durabilidade e a resistência ao manchamento das facetas, e Brito, Ferreira e Yamashita (2022) explicaram que, quando mal executadas, deixam porosidades, falta de brilho e alterações de cor. Cruz et al. (2023) chegaram a listar o acabamento e o polimento mal feitos entre as falhas mais comuns na execução das facetas.

Os instrumentos utilizados variam pouco entre os relatos. Alves, Peres e Lima (2022) citaram discos de óxido de alumínio e tiras de lixa, e Silva, I. et al. (2021) descreveram o uso de pontas abrasivas seguidas de discos de alto brilho e escovas de pelo de cabra. Pereira et al. (2020) removeram os excessos com pontas diamantadas finas e extrafinas, conferiram os contatos oclusais e poliram com borrachas de silicone, discos Sof-Lex e discos de feltro com pasta diamantada. Oliveira et al. (2021) preferiram fazer o acabamento e o polimento sete dias depois

do procedimento, com brocas multilaminadas, discos de granulação decrescente, kit de polimento, discos de feltro e pasta de polimento.

Brito, Ferreira e Yamashita (2022) observaram que o tipo de resina também interfere no resultado dessa etapa, já que as resinas microparticuladas e nanoparticuladas alcançam superfícies mais lisas, o que ajuda a explicar o melhor brilho e o menor manchamento observados por Irgang et al. (2020) nesse tipo de material. Para Soares e Borges (2023), a excelência nessas etapas finais é parte essencial do sucesso e da longevidade das facetas.

3.9 Facetas diretas e o periodonto

A saúde gengival é uma condição para o sucesso das facetas e, ao mesmo tempo, pode ser prejudicada por elas. Santos et al. (2022) realizaram uma revisão integrativa sobre o impacto das facetas diretas no periodonto e alertaram que o uso indiscriminado da técnica pode causar inflamação gengival e outras sequelas. Para evitar esses problemas, defenderam o respeito ao espaço biológico, mantendo-se uma margem gengival mínima de 3 mm. Cruz et al. (2023) também incluíram a invasão do espaço biológico entre as falhas de execução das facetas.

Cruz et al. (2021) relataram as consequências de não respeitar esses princípios: o paciente procurou atendimento insatisfeito com a cor das facetas antigas e com sangramento gengival durante a escovação. O tratamento exigiu a remoção das dez facetas existentes e a confecção de novas, e os autores concluíram que o respeito aos tecidos periodontais é indispensável para evitar retratamentos.

Em outros casos, a correção da gengiva faz parte do próprio tratamento. Silva, B. et al. (2021) realizaram gengivoplastia em uma paciente com grande exposição gengival e, noventa dias depois, fizeram o clareamento e as facetas do dente 15 ao 25. Lima, Amorim e Pereira (2023) associaram a gengivectomia em bisel interno às facetas em uma paciente com sorriso gengival e dentes curtos, explicando que a cirurgia aumenta a coroa clínica enquanto as facetas devolvem forma e cor aos dentes. Nos dois trabalhos, os autores concluíram que a integração entre periodontia e dentística é essencial para um resultado harmônico e duradouro. Joshi (2025) também utilizou o aumento de coroa clínica para corrigir a assimetria gengival antes das facetas.

3.10 Longevidade, falhas e manutenção

A durabilidade das facetas diretas melhorou junto com a evolução dos materiais. Segundo Brito, Ferreira e Yamashita (2022) e Santos et al. (2022), as facetas diretas feitas com as resinas e os adesivos atuais podem durar em torno de 10 anos. Irgang et al. (2020), em um estudo clínico que acompanhou facetas por até dez anos, encontraram taxa de sobrevivência de 77%.

A comparação com as facetas indiretas, no entanto, ainda divide os autores. Galvão et al. (2025) realizaram uma revisão sistemática nas bases PubMed, Embase e Cochrane e, dos 50 artigos encontrados, incluíram cinco estudos clínicos, a maioria mostrando maior sobrevida para as facetas diretas em comparação com as indiretas de resina. Teixeira et al. (2022), por outro lado, revisaram estudos clínicos no PubMed e concluíram que as facetas indiretas de porcelana tiveram sobrevida relativamente maior e mais estabilidade de cor, embora as diretas permitam ajustar forma e cor com mais facilidade. Essa diferença pode ser explicada, em parte, pelo material comparado: no primeiro trabalho, as facetas indiretas eram de resina; no segundo, de porcelana.

Quanto às falhas, os trabalhos apontam causas parecidas. Galvão et al. (2025) identificaram o descolamento e a fratura como os motivos mais frequentes de falha nas duas técnicas. Cruz et al. (2023) concluíram que a principal causa das falhas é o desempenho do próprio cirurgião-dentista, citando anatomia inadequada, ausência de ponto de contato, diferença de cor e preparo incorreto, mas lembraram que fatores do paciente, como forças oclusais, variações de pH, higiene deficiente e hábitos parafuncionais, também podem levar ao descolamento e à fratura. Cruz et al. (2021) ilustraram bem esse cenário, com facetas mal executadas que precisaram ser totalmente refeitas.

Por fim, a manutenção depende da colaboração do paciente. Rocha et al. (2021) destacaram que a falta de higiene favorece a degradação da matriz orgânica da resina e a alteração de cor e textura, e por isso orientaram retornos semestrais para manutenção. Lima et al. (2020) também recomendaram retornos periódicos, e Silva, I. et al. (2021) consideraram os cuidados do paciente fundamentais para a longevidade do material. Tozo-Burgos, Escalante-Otárola e Sánchez-Tito (2025) reforçaram a importância das orientações sobre a dieta, já que bebidas ácidas

degradam a superfície das resinas, e Teixeira et al. (2022) destacaram o uso da placa miorrelaxante em pacientes com bruxismo.

REFERÊNCIAS

ALVES, D. L.; PERES, S. S. C.; LIMA, C. M. Faceta direta em resina composta: indicação e técnica. **Revista Cathedral**, v. 4, n. 1, p. 109-116, 2022.

BASTOS, N. A. et al. Clinical performance of the composite resin veneers: the minimally invasive approach. **Archives of Health Investigation**, v. 7, n. 9, p. 392-396, 2018. DOI: 10.21270/archi.v7i9.3151.

BENTO, M. J. et al. Impacto psicossocial na reabilitação estética anterior com resina composta direta: relato de caso. **Archives of Health Investigation**, v. 10, n. 2, p. 209-214, 2021. DOI: 10.21270/archi.v10i2.5083.

BRITO, J. A. O.; FERREIRA, V. S.; YAMASHITA, R. K. Indicações e longevidade das facetas de resina composta: revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 13, e467111335738, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i13.35738.

CRUZ, A. I. et al. Troca de facetas em resina composta insatisfatórias, buscando adequação anatômica e estética: relato de caso. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 14, e169101421740, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i14.21740.

CRUZ, K. F. et al. As principais falhas na execução de facetas em resina composta em dentes anteriores: revisão de literatura. **Revista Cathedral**, v. 5, n. 3, p. 75-86, 2023.

DIAS, P. et al. Aesthetic restoration using composite resin in teeth with inactive carious lesions: a conservative and predictable approach. **RGO: Revista Gaúcha de Odontologia**, v. 68, e20200052, 2020. DOI: 10.1590/1981-86372020000522018010l.

DOMINGUEZ, G. P. et al. Facetas diretas em resina composta: uma revisão abrangente. **Research, Society and Development**, v. 13, n. 7, e12213746470, 2024. DOI: 10.33448/rsd-v13i7.46470.

FALCÃO, A. et al. Faceta direta de resina composta utilizando pigmentos opacificadores para reabilitação estética anterior de dente escurecido: relato de caso. **Revista Naval de Odontologia**, v. 50, n. 1, p. 15-20, 2023.

FERNANDES, L. K. P. et al. O método de fotopolimerização é capaz de influenciar nos valores de microdureza das resinas compostas? Um estudo in vitro. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 51, e20220043, 2022. DOI: 10.1590/1807-2577.04322.

GALVÃO, B. W. L. et al. Longevidade clínica das facetas diretas e indiretas em resina composta em dentes anteriores: uma revisão sistemática. **RSBO**, v. 22, n. 2, p. 308-321, 2025.

IRGANG, L. et al. A clinical evaluation of direct veneers made with two types of composites. **Journal of Research in Dentistry**, v. 8, n. 1, p. 10-16, 2020. DOI: 10.19177/jrd.v8e1202010-16.

JOSHI, S. Aesthetic smile makeover with direct resin composite veneers: a case report. **Scientiarum: A Multidisciplinary Journal**, v. 1, n. 5, p. 1-5, 2025. DOI: 10.54646/SAPARS.2025.22.

KORKUT, B.; YANIKOĞLU, F.; GÜNDAY, M. Direct composite laminate veneers: three case reports. **Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects**, v. 7, n. 2, p. 105-111, 2013. DOI: 10.5681/joddd.2013.019.

LANZARETTI, G. et al. Esthetic smile rehabilitation with direct composite veneers: a narrative review with a practical explanation of the technique. **Minerva Dental and Oral Science**, v. 74, n. 4, p. 266-272, 2025. DOI: 10.23736/S2724-6329.25.05161-7.

LIMA, A. P. M.; AMORIM, J. C.; PEREIRA, T. S. Reabilitação estética anterior com gengivectomia e facetas em resina composta. **Scientia Generalis**, v. 4, n. 2, p. 93-103, 2023. DOI: 10.22289/sg.V4N2A7.

LIMA, H. E. R. et al. Fechamento de diastema utilizando resina composta. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 12, p. 95036-95045, 2020. DOI: 10.34117/bjdv6n12-115.

NALBANDIAN, S.; MILLAR, B. J. The effect of veneers on cosmetic improvement. **British Dental Journal**, v. 207, E3, 2009. DOI: 10.1038/sj.bdj.2009.609.

OLIVEIRA, L. M. O. et al. Fechamento de diastema pela técnica direta em resina composta: relato de caso clínico. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 16, e431101624060, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i16.24060.

PEREIRA, M. R. et al. Reabilitação estética com resina composta em paciente jovem: relato de caso clínico. **Revista Odontológica do Brasil Central**, v. 29, n. 88, p. 24-28, 2020.

REIS, G. R. et al. Mock-up: previsibilidade e facilitador das restaurações estéticas em resina composta. **Revista Odontológica do Brasil Central**, v. 27, n. 81, p. 105-111, 2018.

ROCHA, A. O. et al. Intervenção estética anterior por meio de facetas diretas em resina composta: relato de caso. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 3, e6439, 2021. DOI: 10.25248/REAS.e6439.2021.

SANTOS, R. G. et al. O impacto das facetas diretas em resina composta sobre o tecido periodontal: revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 7, e54511730235, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i7.30235.

SILVA, B. J. et al. Transformação de sorriso envolvendo cirurgia plástica periodontal e facetas em resina composta: relato de caso. **Revista Odontológica Integrativa do Centro-Oeste**, v. 1, n. 1, p. 75-86, 2021.

SILVA, I. B. et al. Facetas diretas em resina composta: uma abordagem conservadora (revisão da literatura). **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 11, p. 109291-109307, 2021. DOI: 10.34117/bjdv7n11-518.

SOARES, I. S.; BORGES, T. S. Técnicas e indicações para a realização das facetas em resina composta direta: uma revisão integrativa da literatura. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 6, e3312641962, 2023. DOI: 10.33448/rsd-v12i6.41962.

TEIXEIRA, B. C. et al. Longevidade de tratamento reabilitador com facetas diretas e indiretas em dentes anteriores: uma revisão narrativa. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 15, e409111537369, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i15.37369.

TOZO-BURGOS, J. G.; ESCALANTE-OTÁROLA, W.; SÁNCHEZ-TITO, M. Erosive resistance of high-translucency resin composites: new insights for esthetic dentistry. **Journal of Clinical and Experimental Dentistry**, v. 17, n. 12, p. e1508-e1516, 2025. DOI: 10.4317/jced.63433.

VAZ, M. M.; LOPES, G. F.; TOLEDO NETA, M. E. Tratamento reabilitador estético como uma possibilidade para pequenas correções de alinhamento. **Revista Odontológica Integrativa do Centro-Oeste**, v. 2, n. 1, p. 28-42, 2022.

VOOKANTI, V. R. R. et al. Aesthetic transformation of fluorosed teeth using minimally invasive direct composite veneers: a case report. **University Journal of Dental Sciences**, v. 12, n. 1, p. 91-96, 2026. DOI: 10.21276/ujds.2026.12.1.17.